

Relatório de Revisão Clínica: Casos de OSCE e Procedimentos Médicos

Relatório de Revisão Clínica para Avaliação Prática (OSCE)

Orientações Gerais para a Avaliação OSCE

- ****Procedimentos Iniciais Mandatórios:**** Ao entrar na sala, verbalizar a higienização das mãos e solicitar permissão ao paciente para realizar o exame físico. Estes passos são cruciais para a pontuação.
- ****Apresentação Profissional:**** Apresentar-se, mencionando o nome e, se aplicável, o nome do professor/avaliador.

Caso 1: Pneumonia

Paciente: Leandro, 25 anos.

- **Anamnese Dirigida:**
 - ****Tosse:**** Caracterizar início, duração (aguda, não crônica), presença e tipo de expectoração (geralmente purulenta).
 - ****Febre:**** Investigar presença, padrão e intensidade.
 - ****Dor Torácica:**** Questionar sobre dor, especialmente pleurítica (piora com a inspiração profunda).
 - ****Sintomas Associados:**** Dispneia, sudorese noturna.
- **Exame Físico Pulmonar:**
 - ****Inspeção:**** Taquipneia, uso de musculatura acessória (tiragem intercostal, supraclavicular), expansibilidade pulmonar reduzida no hemitórax afetado.
 - ****Palpação:**** Expansibilidade torácica diminuída (ápices e bases, posteriormente), frêmito tóraco-vocal (FTV) aumentado sobre a área de consolidação.
 - ****Percussão:**** Som maciço ou submaciço sobre a área de consolidação. *Nota:* Exame pulmonar realizado com paciente sentado ou em pé.
 - ****Ausculta:**** Murmúrio vesicular (MV) diminuído ou abolido na área afetada, estertores finos (crepitantes) na área de consolidação, broncofonia aumentada (voz nítida e alta ao auscultar “33”) sobre a consolidação, pectorilóquia fônica (palavras distintamente ouvidas), egofonia (“voz de cabra”, som anasalado, “i”

soa como “ê”) pode estar presente na borda superior de derrames pleurais ou consolidações.

Caso 2: Eletrocardiograma (ECG) – Foco em Síndrome Coronariana Aguda

- **Identificação de Alterações Isquêmicas:**
 - Supradesnívelamento do segmento ST (Supra de ST): Indicativo de lesão transmural aguda (IAM com Supra de ST).
 - Infradesnívelamento do segmento ST (Infra de ST): Indicativo de lesão subendocárdica (Angina Instável, IAM sem Supra de ST).
- **Localização Correta dos Eletrodos:**
 - **Eletrodos Periféricos (Plano Frontal):**
 - Vermelho (VD/RA): Pulso direito.
 - Amarelo (VE/LA): Pulso esquerdo.
 - Preto (PD/RL): Tornozelo direito (terra/neutro).
 - Verde (PE/LL): Tornozelo esquerdo.
 - (Mnemônico: “Flamengo no lado direito, Brasil no lado esquerdo do coração”).
 - **Eletrodos Precordiais (Plano Horizontal):**
 - V1: 4º espaço intercostal (EIC), linha paraesternal direita.
 - V2: 4º EIC, linha paraesternal esquerda.
 - V4: 5º EIC, linha hemiclavicular esquerda.
 - V3: Ponto médio entre V2 e V4.
 - V5: 5º EIC, linha axilar anterior esquerda.
 - V6: 5º EIC, linha axilar média esquerda.
- ****Manifestações Clínicas de IAM:**** Dor retroesternal típica (opressão, queimação) com irradiação para membro superior esquerdo, mandíbula, dorso. Elevação de marcadores de necrose miocárdica (ex: troponina).

Caso 3: Asma Brônquica

Paciente: Júlia.

- ****Sintomas Cardinais:**** Opressão torácica, dispneia, sibilância, tosse (predominantemente seca, pode ser produtiva).
- ****Fatores Desencadeantes:**** Exposição a alérgenos (ácaros, pólen, pelo de animais, mofo), irritantes (fumaça de cigarro, poluição), infecções virais, exercício físico, mudanças climáticas. Histórico de atopia pessoal ou familiar.
- **Espirometria para Diagnóstico:**
 - Distúrbio ventilatório obstrutivo: Relação VEF1/CVF reduzida (geralmente < 0,75-0,80 em adultos; < 0,90 em crianças).

- ****Prova broncodilatadora positiva:**** Aumento do VEF1 em $\geq 12\%$ E ≥ 200 mL em relação ao valor pré-broncodilatador (adultos). Em crianças, aumento do VEF1 $\geq 12\%$ OU ≥ 200 mL.

Caso 4: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Paciente: Idoso, fumante.

- ****Características Clínicas:**** Tosse crônica, frequentemente produtiva (expectoração matinal), dispneia progressiva aos esforços, histórico de exposição significativa a fatores de risco (principalmente tabagismo ≥ 20 maços-ano).
- ****Diagnóstico Espirométrico:**** VEF1/CVF $< 0,7$ pós-broncodilatador.
- **Exame Físico:**
 - ****Inspeção:**** Tórax em tonel (aumento do diâmetro anteroposterior), uso de musculatura acessória (em exacerbações ou doença avançada), cianose central (em casos graves com hipoxemia), respiração com lábios semicerrados ("pursed-lip breathing"), expansibilidade torácica globalmente diminuída, taquipneia, dispneia.
 - ****Palpação:**** Expansibilidade diminuída, FTV diminuído (devido à hiperinsuflação pulmonar).
 - ****Percussão:**** Hipertimpanismo ou hipersonoridade difusa.
 - ****Ausculta:**** MV globalmente diminuído, presença de sibilos (especialmente expiratórios) e roncosp, tempo expiratório prolongado, hipofonese de bulhas cardíacas (em casos de enfisema grave).
- ****Achados na Radiografia de Tórax:**** Hipertransparência pulmonar, retificação das cúpulas diafragmáticas, aumento dos espaços intercostais, coração em gota (aspecto alongado e verticalizado), bolas enfisematosas (em alguns casos).

Caso 5: Pneumotórax Hipertensivo

- ****Manifestações Clínicas:**** Dor torácica de início súbito, tipo pleurítica, dispneia intensa e progressiva.
- ****Sinais de Hipertensão (Gravidade):**** Desvio contralateral da traqueia e do mediastino, hipotensão arterial e choque (redução do retorno venoso por compressão da veia cava), turgência de jugulares, cianose.
- **Exame Físico:**
 - ****Inspeção:**** Dispneia, taquipneia, uso de musculatura acessória, expansibilidade torácica diminuída ou ausente no hemitórax afetado, possível abaulamento do hemitórax afetado.
 - ****Palpação:**** Expansibilidade diminuída no lado afetado, FTV abolido ou drasticamente diminuído no lado afetado, desvio da traqueia para o lado contralateral.

- **Percussão:** Hipertimpanismo ou hipersonoridade no hemitórax afetado.
- **Ausculta:** MV abolido ou drasticamente diminuído no hemitórax afetado, hipofonese de bulhas cardíacas (pelo desvio mediastinal).
- **Conduta de Emergência:** Descompressão torácica imediata com agulha (toracocentese de alívio) no 2º EIC na linha hemiclavicular ou 4º/5º EIC na linha axilar anterior/média, seguida de drenagem torácica em selo d'água.

Caso 6: Tuberculose Pulmonar

- **Anamnese:**
 - **Tosse:** Persistente por $\geq 2-3$ semanas, inicialmente seca, podendo evoluir para produtiva (expectoração mucopurulenta, às vezes com hemoptise).
 - **Febre:** Predominantemente vespertina, baixa intensidade.
 - **Sudorese Noturna:** Profusa.
 - **Perda Ponderal:** Inexplicada.
 - **Sintomas Adicionais:** Dispneia, astenia, anorexia, dor torácica.
 - **Epidemiologia:** Contato com caso bacilífero, imunossupressão (HIV, DM, uso de imunossupressores), privação de liberdade, etc.
- **Exame Físico:**
 - **Inspeção:** Sinais de emagrecimento (caquexia em casos avançados), tosse, dispneia, prostração, expansibilidade diminuída (especialmente em ápices ou áreas afetadas).
 - **Palpação:** Expansibilidade diminuída, FTV pode estar aumentado (em áreas de consolidação) ou diminuído (em áreas de cavitação ou fibrose extensa).
 - **Percussão:** Som maciço ou submaciço (sobre consolidação ou derrame pleural associado), som timpânico (sobre grandes cavitações).
 - **Ausculta:** MV diminuído, estertores crepitantes (especialmente em ápices pulmonares, após manobra de tosse), broncofonia (em áreas de consolidação), sopro cavitário ou anfórico (sobre grandes cavidades).

Caso 7: Insuficiência Cardíaca (IC) Descompensada

- **Fatores de Risco/Etiologias Comuns:** Doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, valvopatias, diabetes mellitus, cardiomiopatias.
- **Anamnese:** Dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna (DPN), edema de membros inferiores, fadiga, tosse (especialmente noturna ou aos esforços).
- **Exame Físico:**
 - **Inspeção Geral:** Edema de membros inferiores (simétrico, ascendente, cacofo positivo), ascite, hepatomegalia congestiva (em IC direita ou biventricular), turgência jugular patológica (TJP) a 45º, taquipneia, dispneia.

- **Palpação Cardiovascular:** Pulso arterial pode ser fraco, alternante (em IC grave), ictus cordis (localização, intensidade, extensão; sensibilizar com decúbito lateral esquerdo), refluxo hepatojugular (positivo se a compressão do hipocôndrio direito por 30-60s eleva a TJP).
- **Ausculata Cardíaca:** Focos clássicos (aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral), presença de terceira bulha (B3 – ritmo de galope ventricular, indica disfunção sistólica/sobrecarga de volume), quarta bulha (B4 – galope atrial, indica disfunção diastólica), sopros cardíacos (se valvopatia primária ou secundária à dilatação ventricular).
- **Ausculata Pulmonar (em congestão pulmonar/IC esquerda):** Estertores crepitantes finos bibasais (“maré montante”), sibilos (“asma cardíaca”).
- **Achados na Radiografia de Tórax:** Cardiomegalia (índice cardiorácico > 0,5), sinais de congestão venosa pulmonar (cefalização da trama vascular, linhas B de Kerley, derrame pleural – geralmente bilateral).

Caso 8: Teste do Coraçãozinho (Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênicas Críticas)

- **Indicação:** Recém-nascidos (RN) entre 24 e 48 horas de vida, com idade gestacional ≥ 35 semanas, clinicamente estáveis e assintomáticos.
- **Técnica de Realização:** Ambiente calmo, RN tranquilo ou dormindo, higienização das mãos, uso de oxímetro de pulso com sensor neonatal. **Medição pré-ductal:** SatO2 no membro superior direito (MSD). **Medição pós-ductal:** SatO2 em um dos membros inferiores (MMII).
- **Interpretação dos Resultados:**
 - **Normal (Teste Negativo):** SatO2 $\geq 95\%$ em MSD e MMII, diferença entre SatO2 do MSD e MMII $\leq 3\%$. RN recebe alta hospitalar com seguimento pediátrico de rotina.
 - **Anormal (Teste Positivo – Encaminhar para Ecocardiograma em 24h):**
 - Qualquer medida de SatO2 < 90% (em MSD ou MMII).
 - SatO2 entre 90% e 94% (em MSD ou MMII) OU diferença entre SatO2 do MSD e MMII > 3%:
 - Repetir o teste em 1 hora.
 - Se mantiver alterado, repetir novamente após 1 hora.
 - Se persistir alterado na terceira medição, o teste é considerado positivo.

Caso 9: Aferição e Interpretação da Pressão Arterial (PA) em Crianças

- **Preparo da Criança:** Repouso de 3-5 minutos em ambiente calmo, bexiga vazia, evitar cafeína ou estimulantes nos 30 minutos precedentes.

- ****Técnica de Aferição:****Criança sentada (ou deitada se < 3 anos), pernas descruzadas, braço apoiado ao nível do coração. ****Seleção do Manguito:****Largura da bolsa inflável $\approx 40\%$ da circunferência do braço (ponto médio entre acrômio e olécrano), comprimento cobre 80-100% da circunferência. Manguito 2-3 cm acima da fossa cubital, marcador de artéria sobre a artéria braquial. Método auscultatório, estimar PAS pelo método palpatório antes. Insuflar 20-30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial, desinsuflar lentamente (2-3 mmHg/seg). PAS: Primeiro som de Korotkoff (fase I). PAD: Desaparecimento dos sons (fase V). Realizar pelo menos duas medições com intervalo de 1-2 minutos; se discrepantes, realizar uma terceira. Considerar a média.
- **Classificação da PA em Crianças (Percentis para sexo, idade e altura):**
 - **PA Normal:**< Percentil 90.
 - ****PA Elevada:**** $\geq$ Percentil 90 até < Percentil 95 (ou $\geq 120/80$ mmHg até <P95 para adolescentes ≥ 13 anos).
 - ****Hipertensão Estágio 1:**** $\geq$ Percentil 95 até < Percentil 95 + 12 mmHg (ou 130/80 a 139/89 mmHg para adolescentes ≥ 13 anos).
 - ****Hipertensão Estágio 2:**** $\geq$ Percentil 95 + 12 mmHg (ou $\geq 140/90$ mmHg para adolescentes ≥ 13 anos).
- ****Conduta Inicial:****Diagnóstico de hipertensão requer múltiplas aferições em ocasiões distintas. Orientar pais sobre modificações de estilo de vida (MEV): dieta saudável, atividade física, controle de peso.

Caso 10: Pneumonia em Crianças

- ****Anamnese (com os pais/responsáveis):****Duração da tosse (seca, produtiva), febre (intensidade, padrão), presença de cansaço, dificuldade para respirar, recusa alimentar, prostração, histórico de vacinação, contato com doentes, frequência à creche.
- ****Sinais de Gravidade (Hospitalização):****Tiragem subcostal, intercostal ou de fúrcula, batimento de asas do nariz (BAN), gemência expiratória, cianose central, $\text{SatO}_2 < 92\%$ (ou $< 90\%$ em algumas diretrizes) em ar ambiente, taquipneia (FR elevada para a idade), recusa alimentar/incapacidade de beber/mamar, alteração do nível de consciência (letargia, irritabilidade), convulsões.
- **Exame Físico Pulmonar:**
 - ****Inspeção:****Avaliar padrão respiratório, FR, sinais de gravidade.
 - ****Palpação:****Expansibilidade torácica (difícil em bebês), FTV (avaliar durante o choro, pode estar aumentado na consolidação).
 - ****Percussão:****Macicez ou submacicez sobre a área consolidada.
 - ****Ausculta:****MV diminuído na área afetada, estertores crepitantes finos, sopro tubário (bronco-respiração) sobre a consolidação, broncofonia aumentada.

Caso 11: Asma em Crianças – Avaliação de Controle (Protocolo GINA)

- **Anamnese Focada no Controle (últimas 4 semanas):**

- **Sintomas diurnos:** Tosse, sibilância, dispneia ou opressão torácica > 2 vezes/semana?
- **Limitação de atividades:** A asma interfere nas atividades diárias (brincar, ir à escola)?
- **Despertar noturno:** Acorda à noite devido à asma?
- **Necessidade de medicação de alívio:** Uso de broncodilatador de curta ação (SABA) > 2 vezes/semana?

- **Classificação do Controle da Asma (GINA):**

- **Asma Controlada:** Nenhuma resposta “sim”.
- **Asma Parcialmente Controlada:** 1 ou 2 respostas “sim”.
- **Asma Não Controlada:** 3 ou 4 respostas “sim”.

- **Exame Físico (crise ou intercrise):**

- **Inspeção:** Durante crises, observar dispneia, taquipneia, uso de musculatura acessória, tiragens, BAN, expiração prolongada.
 - **Palpação:** Expansibilidade diminuída simetricamente (crise com hiperinsuflação), FTV reduzido.
 - **Percussão:** Hipersonoridade ou hipertimpanismo (hiperinsuflação).
 - **Auscultação:** MV diminuído, sibilos difusos (predominantemente expiratórios). Em crises graves, “tórax silencioso” (ausência de sibilos com esforço respiratório intenso) é sinal de alarme.
- **Espirometria:** Útil para diagnóstico e monitoramento. Prova broncodilatadora positiva (aumento VEF1 $\geq 12\%$ OU $\geq 200\text{ml}$ em crianças).

Caso 12: Trombose Venosa Profunda (TVP) e Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

- **TVP – Fatores de Risco (Tríade de Virchow):** Estase venosa (imobilização prolongada, cirurgias, viagens longas, paralisia, IC), lesão endotelial (trauma, cirurgia, cateteres venosos, inflamação), hipercoagulabilidade (trombofilias, câncer, gravidez, puerpério, contraceptivos orais, terapia hormonal).
- **TVP – Exame Físico do Membro Afetado:**
 - **Inspeção:** Edema unilateral (panturrilha/tornozelo), eritema, calor local, dilatação de veias superficiais (circulação colateral).
 - **Palpação:** Dor à palpação do trajeto venoso profundo, empastamento da panturrilha.
 - Sinal de Homans: Dor na panturrilha à dorsiflexão passiva do pé (baixa sensibilidade/especificidade).
 - Sinal de Bancroft/Moses: Dor à compressão anteroposterior da panturrilha contra a tíbia.

- ****TEP – Sinais e Sintomas:****Dispneia de início súbito, dor torácica tipo pleurítica, taquipneia, taquicardia, tosse (pode ser com hemoptise), sinais de gravidade (TEP maciço/submaciço: hipotensão, síncope, cianose, turgência jugular, disfunção de VD).
- **Diagnóstico Laboratorial e de Imagem:**
 - ****TEP:****Angiotomografia computadorizada de tórax com contraste (padrão ouro), cintilografia V/Q (alternativa).
 - ****TVP:****Ultrassonografia com Doppler colorido de membros inferiores (exame de escolha).

Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) – Diagnóstico Diferencial

- ****Fatores de Risco Principais:****Tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, idade avançada.
- ****Sintoma Principal:****Claudicação intermitente (dor tipo câibra em MMII, geralmente panturrilhas, desencadeada pelo esforço e que alivia com o repouso). Dor em repouso e lesões tróficas indicam isquemia crítica.
- **Exame Físico dos Membros Inferiores:**
 - ****Inspeção:****Palidez cutânea, rarefação de pelos, pele fina, brilhante e seca, unhas atróficas, palidez à elevação do membro e rubor pendente (Sinal de Buerger), úlceras arteriais (dolorosas, bordas bem definidas, extremidades distais/pontos de pressão).
 - ****Palpação:****Redução ou ausência de pulsos periféricos (pedioso, tibial posterior, poplíteo, femoral), temperatura da pele diminuída (frieza).
- **Diagnóstico – Índice Tornozelo-Braquial (ITB):**
 - Cálculo: $ITB = \frac{\text{Maior PAS do tornozelo (artéria pediosa ou tibial posterior)}}{\text{Maior PAS braquial (direita ou esquerda)}}$
 - **Interpretação:**
 - Normal: 0,91 – 1,30.
 - DAOP Leve: 0,71 – 0,90.
 - DAOP Moderada: 0,41 – 0,70.
 - DAOP Grave (isquemia crítica): $\leq 0,40$.
 - $ITB > 1,30$: Sugere artérias não compressíveis (calcificação arterial), comum em diabéticos e idosos. Necessita outros métodos.

Revisão de Valvopatias

- **Estenose Aórtica (EAo):**
 - ****Etiologias:****Degenerativa/calcífica (idosos), valva aórtica bicúspide congênita, febre reumática.
 - ****Tríade Sintomática Clássica:****Angina, síncope aos esforços, dispneia (IC).

- **Ausculata Cardíaca:** Sopro sistólico ejetivo (em diamante, crescendo-decrescendo), rude, foco aórtico, irradiação para fúrcula esternal e carótidas. Click de ejeção aórtico (se valva flexível). B2 hipofonética ou desdobramento paradoxal (casos graves).
- **Palpação:** Pulso arterial *parvus et tardus* (pequena amplitude e ascensão lenta), frêmito sistólico em foco aórtico e fúrcula, ictus cordis sustentado.
- **Estenose Mitral (EMi):**
 - **Etiologia Principal:** Febre reumática.
 - **Sintomas:** Dispneia (principal, progressiva), ortopneia, DPN, hemoptise, rouquidão (Sinal de Ortner – compressão do nervo laríngeo recorrente pelo átrio esquerdo aumentado), disfagia. Fibrilação atrial é comum.
 - **Ausculata Cardíaca:** Sopro diastólico em ruflar, baixa frequência, foco mitral, melhor audível em decúbito lateral esquerdo com campânula. Estalido de abertura da valva mitral (após B2). B1 hiperfonética.
- **Insuficiência Aórtica (IAo):**
 - **Etiologias:** Dilatação da raiz da aorta (HAS, síndrome de Marfan, aortites), doença valvar primária (febre reumática, endocardite infecciosa, valva bicúspide).
 - **Fisiopatologia:** Refluxo de sangue da aorta para o VE durante a diástole, causando sobrecarga de volume no VE.
 - **Sintomas:** Dispneia aos esforços, palpitações, angina (casos crônicos graves).
 - **Sinais Periféricos (pressão de pulso diferencial):**
 - Pulso arterial em “martelo d’água” (Corrigan) ou Celer (amplo, ascensão/descenso rápidos).
 - Pressão arterial divergente (PAS elevada, PAD baixa).
 - Sinal de Musset (movimentos da cabeça sincrônicos com o pulso).
 - Sinal de Quincke (pulsção capilar no leito ungueal).
 - Sinal de Müller (pulsção da úvula).
 - Sopro de Duroziez (sopro sistólico e diastólico na artéria femoral à compressão proximal e distal).
 - **Ausculata Cardíaca:** Sopro diastólico aspirativo, alta frequência, decrescendo, foco aórtico e foco aórtico acessório (Erb), melhor audível com paciente sentado e inclinado para frente, em expiração forçada. Sopro de Austin Flint (ruflar diastólico em foco mitral, funcional, devido ao jato da IAo sobre o folheto anterior da mitral). Ictus cordis hiperdinâmico, desviado para baixo e para esquerda.
- **Insuficiência Mitral (IMi):**
 - **Etiologias:** Prolapso de valva mitral, febre reumática, doença arterial coronariana (disfunção/ruptura de músculo papilar), endocardite infecciosa, dilatação do VE.

- ****Fisiopatologia:****Refluxo de sangue do VE para o AE durante a sístole.
- ****Ausculta Cardíaca:****Sopro holossistólico (pansistólico) regurgitativo, timbre variável (geralmente rude ou em jato de vapor), foco mitral, irradiação para axila e região infraescapular esquerda. B1 pode ser hipofonética. B3 presente se disfunção ventricular significativa.

SOPROS PELA CLÍNICA

• Estenose aórtica

- Angina, síncope ao esforço e dispneia
 - ↳ falou em perdo de consciência
- Pulso parvo e tardus
- Geralmente idoso

• Insuficiência aórtica

- Dispneia progressiva aos esforços
- Palpitações
- Pulso em martelo d'água (amplo, forte)
- Sinais periféricos
 - ↳ pulso saltitante (corrigon)
 - ↳ Pulso visível nos pulsos (quinke)
 - ↳ Sinal de Murret (edema vai p/ frente e p/ trás)

• Estenose mitral

- Paciente geralmente jovem e com histórico de febre reumática na infância)
- dispneia progressiva, ortopneia e dispneia paroxística noturna
- hemoptise - Rouquide (nervo laríngeo recorrente)

- ****Fisiopatologia:****Refluxo de sangue do VE para o AE durante a sístole.
- ****Ausculta Cardíaca:****Sopro holossistólico (pansistólico) regurgitativo, timbre variável (geralmente rude ou em jato de vapor), foco mitral, irradiação para axila e região infraescapular esquerda. B1 pode ser hipofonética. B3 presente se disfunção ventricular significativa.

• Insuficiência mitral

- Pode surgir após IAM
- Dispneia súbita intensa
- Edema, congestão
- Holossistólico que irradia p/ axila